ONEMA-POP-008 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-008 — Conduta diante de Tração ou Deslocamento Acidental de Sonda Vesical de Demora

1. Identificação institucional

983558

2. Objetivo e abrangência

Padronizar reconhecimento de lesão, contenção de riscos e encaminhamento após tração ou saída de cateter vesical. Atendimento domiciliar presencial ou orientação digital conforme indicação; não substitui assistência de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado avalia e encaminha; eventual nova sondagem requer indicação atual, ausência de suspeita de lesão uretral, competência técnica, prescrição/protocolo e condições assépticas. Não reinserir automaticamente. Indicações: Tração acidental, cateter parcialmente exteriorizado, saída completa, sangramento, dor ou falha de drenagem após evento. Limites/contraindicações: Suspeita de trauma uretral, sangue no meato, dor intensa, resistência,

retenção aguda com sofrimento, lesão pélvica, cirurgia urológica recente: não manipular/reintroduzir no domicílio; avaliação médica urgente.

4. Materiais e responsabilidade de fornecimento

Enfermeiro: EPI, gaze estéril para proteção externa se necessário, sinais vitais, material de registro e telefone. Materiais para eventual nova sondagem somente após indicação e checagem formal; paciente fornece consumíveis específicos conforme contrato.

5. Avaliação e preparação

Identificar motivo da sondagem, data de inserção, calibre e tipo, balão, evento e força de tração, volume drenado, dor, sangramento, diurese, distensão suprapúbica, febre, anticoagulantes e cirurgia recente.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar evento, horário e se a sonda está parcialmente deslocada ou completamente exteriorizada; manter paciente

em repouso relativo e explicar que não deve puxar ou empurrar o cateter.

2. Verificar sinais de choque, hemorragia significativa, dor intensa, retenção urinária, febre com instabilidade e trauma

associado; se presentes, acionar SAMU 192/urgência.

3. Inspecionar externamente sem tracionar: sangue no meato, lesão, posição da sonda e do coletor; não tentar recolocar

sonda deslocada nem insuflar balão para “fixar”.

4. Se a sonda saiu por completo, preservar dispositivo para avaliação e observar, sem manipular o balão; não realizar

irrigação ou introdução às cegas.

5. Registrar sintomas, último horário de micção/diurese, necessidade original do cateter e fatores de risco; discutir

prontamente com serviço prescritor/urologia a necessidade de nova cateterização.

6. Se houver suspeita de lesão uretral, sangue no meato, resistência ou história urológica complexa, suspender tentativa

de sondagem e encaminhar para avaliação especializada.

7. Se avaliação clínica e protocolo autorizarem nova inserção em cenário sem trauma, executar apenas por profissional

habilitado, com técnica asséptica e materiais estéreis; documentar indicação e resposta, sem transformar em conduta automática.

8. Após definição, conferir drenagem e sistema fechado quando aplicável; orientar fixação sem tensão, bolsa abaixo da

bexiga e sinais de retorno imediato.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Interromper manipulação e encaminhar se sangue no meato, dor/ resistência, sangramento progressivo, ausência de drenagem com distensão, instabilidade, cirurgia recente ou suspeita de lesão.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar prevenção de tração, fixação adequada, cuidado com coletor e avaliação da necessidade de manutenção da sonda; retorno se febre, hematúria, dor ou anúria.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação e consentimento; modalidade; horário de início e evolução; queixas, antecedentes e sinais objetivos; avaliação e decisão clínica; ações e responsáveis; acionamentos e horários; resposta, orientações, destino e continuidade; assinatura do enfermeiro e trilha de auditoria na Carteira Digital ONEMA.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC. Guideline for Prevention of CAUTI — Summary of Recommendations

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html

CDC. CAUTI Prevention Guideline — versão revisada

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/index.html

Best Evidence for Preventing UTI and Optimizing Care in Adults with Indwelling Urinary Catheters (2025) — atenção: síntese secundária, não substitui avaliação urológica

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12619583/

Pontos para revisão do RT: escopo de autonomia e protocolos locais; aplicabilidade ao atendimento remoto; compatibilidade de insumos e dispositivos; fluxo de referência/contrarreferência; verificação de versão e seção de cada fonte.